

2026년 제9차 약제급여평가위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.09.04

항목	내용
회의	2026년 제9차 약제급여평가위원회
회의일	2026년 9월 3일(목)
보고일	2026년 9월 4일(금)
보고 대상	보험약가 · Market Access Leadership
공식 확인	심평원 공식 보도자료 D+1 확인
핵심 결과	결정신청 6품목 중 5품목 「급여의 적정성이 있음」, 림카토주 「평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음」. 위험분담계약 사용범위 확대는 옴디보 ESCC 1차 및 옴디보+여보이 간세포암 1차 적정, 옴디보+여보이 악성 흉막중피종 1차 미적정

§ 1 들어가며

2026년 제9차 약제급여평가위원회는 9월 3일 개최됐고, 심평원은 같은 날 심의결과를 공개했다. 이번 결과표는 하반기 약평위의 안건 범위가 항암제 전환 후보에만 머물지 않고 신경·희귀질환, 피부질환, 혈액암, 세포치료제, 면역항암제 사용범위 확대까지 넓게 구성될 수 있음을 보여준다.

가장 중요한 메시지는 두 가지다. 첫째, 림카토주는 국내 CAR-T 급여 논의에서 「평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음」이라는 조건부 긍정 결론을 받았다. 이는 임상적 필요성은 인정하되 최종 접근성은 가격수용과 후속 협상에 좌우된다는 뜻이다. 둘째, 옴디보+여보이는 같은 병용조합 안에서도 간세포암 1차는 적정, 악성 흉막중피종 1차는 미적정으로 갈렸다. 앞으로 면역항암 병용요법은 약물 조합 단위가 아니라 적응증·라인·근거 수준 단위로 분리해 읽어야 한다.

이번 차수에는 MSD 직접 품목인 키트루다는 포함되지 않았다. 다만 면역항암 병용요법의 급여범위 확대 판단, CAR-T 가격수용 조건, 후속치료 대장암 신약의 급여 적정성 인정은 MSD 포트폴리오와 협상 전략에 간접적인 read-through를 제공한다.

§ 2 본 차수 심의 결과

결정신청 약제의 요양급여 적정성 심의결과

품목	성분	회사	대상·효능효과 요지	심의 결과
비브가트주	에프가티지모드알 파	한독	항아세틸콜린 수용체 항체 양성 전신 중증 근무력증 성인 환자의 표준요법 부가요법	급여의 적정성이 있음
질브리스큐프리필 드시린지주	질루코폴란타륨	한국유씨비제약	항아세틸콜린 수용체 항체 양성 성인 전신 중증근무력증 표준요법 부가요법	급여의 적정성이 있음
림카토주	안발캅타젠오트류 셀	큐로셀	두 가지 이상의 전신치료 후 재발성·불응성 DLBCL 및 PMBCL 성인 환자	평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음
텍베일리주	테클리스타맙	한국안센	3차 이상 치료 후 재발 또는 불응성 다발골수종 성인 환자 단독요법	급여의 적정성이 있음
앤쥬고크림	델고시티닙	레오파마	국소 스테로이드 치료에 반응하지 않거나 적절하지 않은 성인의 중등도~중증 만성 손 습진	급여의 적정성이 있음
프루자클라캡슐	프루퀸티닙	한국다케다제약	표준 항암화학요법과 항-VEGF, 항-EGFR 치료 이후 전이성 결장직장암	급여의 적정성이 있음

위험분담계약 약제의 사용범위 확대 적정성 심의결과

품목	대상·효능효과 요지	심의 결과	해석 포인트
옵디보주	PD-L1 발현 양성 절제불가능 진행성 또는 전이성 식도 편평세포암 1차, 플루오로피리미딘계·백금 기반 화학요법 병용	급여범위 확대의 적정성이 있음	ESCC 1차 면역항암 병용의 접근성 확대 신호
옵디보주+여보이주	절제불가능 또는 전이성 간세포암 1차, 이필리무맙 병용	급여범위 확대의 적정성이 있음	면역항암 병용요법의 간세포암 1차 급여 프레임 확대
옵디보주+여보이주	수술이 불가능한 악성 흉막중피종 1차, 이필리무맙 병용	급여범위 확대의 적정성이 없음	동일 조합이라도 적응증별 임상·경제성 근거에 따라 분리 판단

이번 결과표는 신규 결정신청과 기존 RSA 약제의 사용범위 확대가 함께 처리된 차수다. 단순히 “긍정 품목 수”를 세는 것보다, 무조건 적정·조건부 적정·사용범위 확대 적정·사용범위 확대 미적정을 분리해 후속 절차를 예측하는 것이 중요하다.

§ 3 시장·정책 시사점

1. 조건부 적정은 임상 가치 인정과 가격수용 요구를 동시에 담는다

림카토주의 「평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음」은 국내 첫 CAR-T 급여 논의에서 가격수용 조건이 명시됐다는 점에서 중요하다. 세포치료제는 단회 투여 고가 치료라는 특성상 급여 인정 자체보다 실제 평가금액 수용 여부와 후속 협상 구조가 환자 접근성을 결정한다. 같은 CAR-T 또는 ATMP 계열에서 향후 성과기반계약, 환급형·총액제한형 위험분담, 치료기관 제한, 재투여 기준 등이 어떻게 설계될지 관찰해야 한다.

2. 면역항암 병용요법은 적응증별 split decision이 표준이 되고 있다

옵디보+여보이는 간세포암 1차에서는 적정, 악성 흉막중피종 1차에서는 미적정으로 공개됐다. 이는 같은 약제 조합이라도 질환별 비교약제, 생존자료, 대체치료 접근성, 환자 수, 재정영향의 조합이 다르면 결과가 달라진다는 뜻이다. 키트루다 병용요법을 포함한 모든 면역항암제 확대 전략은 “조합 자체의 급여 가능성”이 아니라 indication-by-indication으로 근거와 재정영향을 재구성해야 한다.

3. 중증근무력증 치료제 2품목 동시 적정은 비항암 희귀·자가면역 영역의 접근성 확대 신호다

비브가트와 질브리스큐가 같은 전신 중증근무력증 영역에서 나란히 급여 적정성을 인정받았다. 이는 비항암 희귀·자가면역 영역에서도 복수 기전의 고가 치료제가 동시에 약평위 결과표에 올라올 수 있음을 보여준다. 경쟁 약제 간 환자군 구분, 표준요법 부가 위치, 투여 편의성, 장기 유지치료 비용이 후속 급여기준과 시장 분화의 핵심 변수가 될 것이다.

4. 후속치료 대장암과 다발골수종은 late-line 접근성 확대 흐름을 이어간다

프루자클라와 텍베일리는 각각 전이성 결장직장암 후속치료와 재발·불응성 다발골수종 후속치료에서 긍정 결론을 받았다. 두 영역 모두 기존 치료 실패 이후의 옵션이 제한적이고, 치료 라인이 길어질수록 환자군 규모와 비용효과성 불확실성이 커진다. 이번 결과는 late-line oncology에서도 임상적 필요와 비교약제 설정이 설득될 경우 급여 적정성 인정 가능성이 유지되고 있음을 보여준다.

§ 4 MSD 자산 직접 영향

이번 차수에 MSD 직접 품목은 없음

이번 공식 결과표에는 키트루다를 포함한 MSD 직접 품목이 수록되지 않았다. 따라서 즉각적인 MSD 품목 급여기준 변경이나 신규 약가협상 진입은 이번 차수에서 발생하지 않았다.

그러나 면역항암 병용 프레임은 키트루다 전략에 직접 read-through가 있다

옵디보와 옵디보+여보이의 사용범위 확대 결과는 키트루다 병용요법에도 중요한 비교 기준을 제공한다. ESCC 1차, 간세포암 1차, 악성 흉막중피종 1차는 모두 면역항암 병용요법의 임상·경제성 근거를 indication-specific하게 평가받는 영역이다. 특히 한 조합 내에서도 간세포암과 흉막중피종의 결론이 갈린 점은, 향후 키트루다 병용 급여 확대에서도 질환별 생존자료와 comparator narrative를 별도로 준비해야 함을 시사한다.

파드셉+키트루다 협상 모니터링은 계속 최우선이다

이번 약평위는 파드셉+키트루다 병용요법의 급여 적용 지연 문제를 직접 해결하지 않는다. 다만 late-line oncology와 면역항암 병용 확대가 동시에 논의되는 환경에서, 키트루다 병용요법의 적응증별 약가 분리, 병용 상대 약제와의 가격 분담, 10월 이후 건정심 논의 가능성은 계속 별도 트랙으로 관리해야 한다.

ATMP·희귀질환 가격수용 조건은 고가 혁신치료제 전반의 협상 기준선이다

림카토 조건부 적정은 MSD 직접 품목은 아니지만, 고가 혁신치료제에서 “임상가치 인정 후 가격수용 조건”을 명확히 하는 최근 약평위 패턴을 강화한다. 향후 고가 항암·희귀질환 자산은 결과표 발표 이전부터 평가금액 수용 시나리오, risk-sharing option, 환자군 제한 근거를 병렬로 준비하는 것이 필요하다.

§ 5 다음 차수 안건 후보

다음 약평위와 암질심에서는 이번 차수에 미상정된 장기 대기 항암 전환 후보와 9차에서 확인된 신규 긍정 품목의 후속 협상 경로를 함께 봐야 한다.

후보·영역	현 단계	다음 확인 포인트
사이람자	1차 암질심 통과 후 약평위 미상정 지속	경평소위 통과, 결정신청 공식 신호, 가격수용 readiness 확인 전까지 상정 가능성 과대평가 금지
엘라히어	5차 암질심 통과 후 약평위 미상정 지속	FRα 양성 난소암에서 환자군·비교약제·재정영향 자료 보완 여부 추적
버제니오	5차 암질심 통과 후 약평위 미상정 지속	조기 유방암 장기 보조요법의 투여기간·중단기준·BIA 구조 확인
림카토	9차 약평위 조건부 적정	평가금액 수용 여부, NHIS 협상 진입, 고가 세포치료제 급여기준 세부조건 확인
비브가트·질브리스큐	9차 약평위 적정	전신 중증근무력증 급여기준 세분화, 표준요법 부가 위치, 경쟁 구도 관찰
옵디보·옵디보+여보이	9차 약평위 RSA 확대 일부 적정·일부 미적정	면역항암 병용요법의 적응증별 근거 차이와 키트루다 병용 전략 read-through 정리
8차 암질심	2026년 9월 30일 예정	키트루다 재도전 신호, 이전 미설정·재논의 품목의 보완자료 제출 여부, regimen-level split decision 가능성 추적

§ 6 Leadership actions

1. 결과 문구별 후속 절차를 분리 관리한다. 림카토는 조건부 적정이므로 평가금액 수용 여부를 별도 체크포인트로 두고, 비브가트·질브리스큐·텍베일리·앤쥬고·프루자클라는 급여 적정성 인정 이후 협상·고시 진입 속도를 추적한다.

2. 면역항암 병용요법은 적응증별 evidence pack으로 재정리한다. 옵디보+여보이의 HCC 적정과 MPM 미적정 차이를 comparator, survival endpoint, budget impact, unmet need 축으로 분해해 키트루다 병용 전략에 반영한다.
3. MSD 직접 현안은 파드셉+키트루다 협상 트랙으로 분리 유지한다. 이번 약평위 결과와 별개로 9월 급여 적용 지연, 10월 건정심 가능성, 적응증별 약가 분리 수용 여부를 leadership watch item으로 유지한다.
4. 다음 예측 모델은 product-level 공식 신호를 더 엄격히 요구한다. 장기 대기 항암 후보는 여전히 watchlist에 남기되, 대기기간만으로 상정 가능성을 높이지 않고 경쟁소위·결정신청·회사 가격수용 신호를 우선한다.

§ 7 출처 및 해석 범위

- 건강보험심사평가원, 「2026년 제9차 약제급여평가위원회 심의결과 공개」, 2026년 9월 3일 배포.
- 본 보고서는 심평원 공식 결과표의 품목·효능효과 요지·심의 결과 문구를 기준으로 작성했다.
- 본 보고서는 약평위 결과 이후 시장·정책·MSD 포트폴리오 관점의 해석을 제공하지만, 최종 급여 등재일·최종 약가·세부 급여기준은 후속 협상, 건강보험정책심의회, 보건복지부 고시 단계에서 확정된다.